



Manual de Bolso da Psicofarmacologia

Guia de consulta rápida para terapeutas

Dra. Tatiana Gontijo

Sumário

	Introdução	3
	Como usar o manual	4
	As Grandes Classes	5
	MEDICAÇÕES	
01	ESCITALOPRAM	8
02	CLONAZEPAM	9
03	QUETIAPINA	10
04	METILFENIDATO	11
05	SERTRALINA	12
06	FLUOXETINA	13
07	ALPRAZOLAM	14
08	DIAZEPAM	15
09	RISPERIDONA	16
10	OLANZAPINA	17
11	ARIPIPRAZOL	18
12	LISDEXANFETAMINA	19
13	LÍTIO	20
14	LAMOTRIGINA	21
15	VALPROATO (ÁCIDO VALPROICO)	22
16	BUPROPIONA	23
17	MIRTAZAPINA	24
18	TRAZODONA	25
19	VENLAFAXINA (E DULOXETINA)	26
20	BUSPIRONA	27
21	PREGABALINA	28
22	CARBAMAZEPINA	29
23	HALOPERIDOL	30
24	ZOLPIDEM	31

Introdução

O paciente menciona um nome que você não reconhece. Ou traz uma bula dobrada e pergunta: "Você sabe o que isso faz?" Você sabe que a pergunta importa. E sabe que responder com clareza faz parte do acompanhamento.

Somos nós que acompanhamos o paciente toda semana, que notamos quando algo mudou, que ouvimos o que ele não contou ao psiquiatra. Essa posição tem valor clínico, e ela exige um tipo específico de conhecimento: o da leitura do que aparece na sessão.

Este manual foi criado para isso. Cada ficha apresenta uma medicação do ponto de vista do que aparece na sessão: o que o paciente relata, o que é possível observar, onde a leitura clínica pode se confundir e quais perguntas ajudam a investigar sem invadir. O objetivo não é decorar classes farmacológicas. É reconhecer o que a medicação faz na presença do sujeito que você acompanha.

Como usar este manual

Este material foi desenhado para ser uma consulta rápida e prática. Cada ficha está dividida em campos que respondem às dúvidas mais comuns do terapeuta:

- **O que o paciente relata:** A linguagem subjetiva do efeito.
- **O que observar:** Mudanças objetivas de comportamento e afeto.
- **Efeitos que confundem:** Onde a clínica pode 'enganar' o terapeuta.
- **Perguntas úteis:** Como investigar o efeito sem ser invasiva.
- **Alertas de Urgência:** Sinais que exigem contato imediato com o médico.

Tenha-o sempre à mão (ou no tablet/celular) durante o atendimento ou na preparação do caso.

As Grandes Classes

Antes de entrar nas fichas individuais, é útil entender como as seis grandes famílias de psicofármacos funcionam na prática e como seus efeitos aparecem no setting terapêutico.

1. Antidepressivos (ISRS, Duais, Tricíclicos)

O que fazem: Alteram a disponibilidade de neurotransmissores (como serotonina e noradrenalina) para melhorar humor, energia e ansiedade crônica. Não são pílulas da felicidade; eles 'limpam a lente' para o paciente conseguir trabalhar em terapia.

Na clínica: Demoram de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Nos primeiros dias, o paciente pode sentir *piora* da ansiedade. Em longo prazo ou doses altas, preste atenção no *embotamento emocional* ('fiquei anestesiado, não consigo chorar').

2. Benzodiazepínicos e Ansiolíticos

O que fazem: 'Freiam' o sistema nervoso central. São apagadores de incêndio para picos de ansiedade aguda, ataques de pânico e insônia pontual.

Na clínica: O efeito é imediato (minutos a horas). O grande risco é a dependência e a tolerância (precisar de mais para o mesmo efeito). Na sessão, o paciente sob efeito pode parecer mais lento, levemente sedado ou com lapsos de memória recente.

3. Estabilizadores de Humor

O que fazem: Seguram os 'polos'. Evitam as subidas (manias/hipomanias) e descidas (depressões) abruptas, formando a base do tratamento da bipolaridade.

Na clínica: Eles ajudam o paciente a ter uma linha de base emocional para poder elaborar questões na terapia. Não tiram a tristeza normal da vida, mas evitam que a tristeza vire um buraco negro. Exigem adesão rigorosa.

4. Antipsicóticos (Neurolépticos)

O que fazem: Desenvolvidos para delírios e alucinações (psicoses), hoje são muito usados em doses baixinhas para 'desligar a mente' à noite, tratar ansiedade severa ou irritabilidade grave.

Na clínica: Costumam 'esfriar' e sedar bastante no início. Podem causar rigidez muscular, tremores leves ou lentificação motora (efeitos extrapiramidais) que você consegue notar visualmente na sessão.

5. Estimulantes (Medicações para TDAH)

O que fazem: Aumentam dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. O objetivo não é 'acelerar', mas dar *foco, atenção e controle de impulsos* para mentes dispersas.

Na clínica: O paciente medicado costuma ficar mais linear e organizado na fala. Como o efeito passa em algumas horas, observe o horário da sessão: um paciente à noite pode estar em 'rebote' (exausto ou muito irritado quando o remédio sai do corpo).

6. Medicações para o Sono (Hipnóticos/Sedativos)

O que fazem: Induzem ou mantêm o sono, 'desligando' a vigília do cérebro.

Na clínica: Extremamente úteis para tirar o paciente do esgotamento agudo, mas não curam a causa emocional da insônia. Se o paciente toma muito tarde, pode chegar 'de ressaca' (sonolento, confuso) na sessão da manhã seguinte. Alguns causam comportamentos noturnos sem memória no dia seguinte.

01 ESCITALOPRAM

ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Na linguagem da sessão: antidepressivo usado com frequência em depressão e ansiedade.

Nome

Escitalopram. Também aparece como oxalato de escitalopram. Nomes comerciais comuns incluem Lexapro, Exodus, Reconter, Esc e similares.

Uso comum

Quadros depressivos, ansiedade generalizada, pânico, ansiedade social e outros quadros ansiosos, conforme avaliação médica.

O paciente pode relatar

- Estou menos desesperado
- parece que a ansiedade baixou
- não choro mais
- minha libido sumiu
- não estou triste, mas também não sinto muita coisa
- nas primeiras semanas fiquei enjoado ou estranho

O que observar em sessão

Redução de ansiedade corporal, menos choro, mais estabilidade para elaborar temas difíceis, mas também possível diminuição de reatividade emocional, menor acesso afetivo, sonolência, inquietação inicial ou queda de desejo sexual.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A melhora pode parecer "frieza" quando há embotamento. A adaptação inicial pode parecer piora da ansiedade. A disfunção sexual pode virar afastamento relacional ou abandono silencioso. Uma melhora rápida demais, com menos sono e aceleração, pode exigir atenção para ativação maniforme.

Perguntas úteis

- Isso começou antes ou depois da medicação?
- Você está melhor ou está sentindo menos tudo?
- Como ficaram sono, energia, libido e apetite?
- Você pensou em parar por conta própria?
- Essa mudança parece uma melhora estável ou uma aceleração fora do seu padrão?

Amarelo: alinhar em breve

- Embotamento importante
- disfunção sexual com risco de abandono
- náusea ou sonolência que ameaça adesão
- piora nas primeiras semanas
- desejo de parar sem consulta
- sintomas persistentes apesar de uso regular

Vermelho: tratar como urgência

- Ideação suicida nova ou intensificada
- agitação intensa com impulsividade
- redução de sono sem cansaço
- sinais de síndrome serotoninérgica
- confusão mental importante ou comportamento muito diferente do padrão basal

Frase clínica

"A tristeza baixou, mas a vida inteira também ficou mais baixa."

Cuidado ético

Não dizer que o escitalopram "causou" o quadro. Organize temporalidade, impacto funcional e fala literal do paciente para o psiquiatra avaliar.

02 CLONAZEPAM

Benzodiazepínico. Na linguagem da sessão: medicação com efeito ansiolítico, sedativo, anticonvulsivante e relaxante, usada em contextos específicos conforme avaliação médica.

Nome

Clonazepam. Nome comercial muito conhecido: Rivotril. Também aparece como genérico.

Uso comum

Crises de ansiedade, pânico, insônia associada à ansiedade, alguns quadros neurológicos e situações em que o médico considera necessário reduzir ativação intensa.

O paciente pode relatar

- Só durmo se tomar
- sem ele eu não funciono
- me acalma rápido
- acordo grogue
- minha memória piorou
- fui aumentando porque parou de fazer efeito
- tenho medo de ficar sem

O que observar em sessão

Sonolência, lentificação, fala mais arrastada, menor elaboração emocional, esquecimento de conteúdos trabalhados, dependência psicológica da medicação como recurso único de regulação, ansiedade antecipatória quando o paciente imagina ficar sem.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Sedação pode parecer depressão ou desmotivação. Lentificação cognitiva pode parecer déficit atencional. Abstinência ou uso irregular pode parecer recaída ansiosa. Tolerância pode levar o paciente a acreditar que "o problema voltou", quando o padrão precisa ser reavaliado pelo prescritor.

Perguntas úteis

- Há quanto tempo você usa?
- É uso diário ou eventual?
- O que acontece quando você não toma?
- Você já precisou aumentar para ter o mesmo efeito?
- Você mistura com álcool ou outros sedativos?
- Você lembra bem do que conversamos nas sessões?

Amarelo: alinhar em breve

- Uso diário por semanas ou meses
- medo intenso de ficar sem
- aumento progressivo
- queixa de memória ou lentidão
- sedação diurna
- uso junto com álcool ou outras substâncias
- paciente tentando parar sozinho

Vermelho: tratar como urgência

- Confusão importante
- queda ou risco físico por sedação
- mistura com álcool/opioides/outras depressores
- desmame abrupto com sintomas intensos
- risco de abstinência grave
- ideação suicida associada a uso impulsivo de medicação

Frase clínica

"O remédio que acalma a crise começou a organizar a vida inteira em torno dele."

Cuidado ético

Retirada de benzodiazepínicos exige avaliação e plano médico. Se o paciente mencionar intenção de reduzir, informe ao psiquiatra antes de qualquer orientação.

03 QUETIAPINA

Antipsicótico atípico. Na linguagem da sessão: medicação que pode aparecer em quadros psicóticos, transtorno bipolar, estabilização do humor e, em alguns contextos médicos, sono.

Nome

Quetiapina. Também aparece como hemifumarato de quetiapina. Nome comercial muito conhecido: Seroquel.

Uso comum

Esquizofrenia, transtorno bipolar, episódios de mania, depressão bipolar e outros contextos em que o médico busca reduzir desorganização, agitação, alteração perceptiva, instabilidade de humor ou insônia relevante.

O paciente pode relatar

- Esse remédio me derruba
- eu durmo, mas acordo pesado
- minha fome aumentou muito
- engordei rápido
- fico mais lento
- as vozes ou pensamentos estranhos diminuíram
- tomo só para dormir

O que observar em sessão

Sonolência, lentificação, queda de energia, menor agitação, discurso mais organizado quando havia desorganização prévia, mas também possível embotamento, prejuízo de atenção, ganho de peso, vergonha corporal, tontura ao levantar e menor participação ativa na sessão.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Sedação pode parecer depressão, desmotivação ou resistência. Redução de agitação pode ser melhora real, mas também pode vir com prejuízo de funcionamento. Ganho de peso pode gerar abandono silencioso. Uso entendido pelo paciente como "remédio para dormir" pode esconder que há uma indicação psiquiátrica mais ampla.

Perguntas úteis

- Você sabe qual foi o objetivo do médico ao prescrever?
- Você está usando para sono, humor, pensamentos acelerados ou outro motivo?
- Como ficam seu corpo e sua cabeça no dia seguinte?
- Percebeu aumento de fome ou peso?
- Tem tontura ao levantar?
- A terapia ficou mais possível ou mais distante?
- Apareceu rigidez, tremor, febre ou confusão?

Amarelo: alinhar em breve

- Sonolência que impede participação na sessão
- Identificação importante
- ganho de peso rápido
- aumento de apetite com sofrimento
- tontura ou quedas
- constipação relevante
- abandono por efeito colateral
- paciente usando de forma diferente da prescrição
- dúvida sobre objetivo clínico do uso

Vermelho: tratar como urgência

- Febre alta com rigidez
- confusão
- sudorese ou alteração de pressão; movimentos involuntários intensos; queda com risco físico; desorganização grave; ideação suicida nova ou intensificada; sinais físicos importantes associados a alteração do estado mental

Frase clínica

"O paciente ficou mais calmo, mas a sessão também ficou mais lenta e distante."

Cuidado ético

Não reduzir a quetiapina a "remédio para dormir" nem interpretar sedação como melhora automática. Observe impacto funcional e alinhe com o psiquiatra quando o efeito atrapalha o trabalho terapêutico.

04 METILFENIDATO

Estimulante do sistema nervoso central. Na linguagem da sessão: medicação usada principalmente em TDAH para atenção, impulsividade e funcionamento executivo, conforme avaliação médica.

Nome

Metilfenidato. Nomes comerciais conhecidos incluem Ritalina e Concerta, além de apresentações genéricas.

Uso comum

TDAH em crianças, adolescentes e adultos, além de outros contextos específicos avaliados pelo médico. No consultório, costuma aparecer quando o paciente relata dificuldade persistente de foco, organização, impulsividade, procrastinação ou desregulação de rotina.

O paciente pode relatar

- Agora consigo começar e terminar tarefas
- minha cabeça ficou mais silenciosa
- fiquei mais ansioso
- perdi a fome
- não consigo dormir
- quando passa o efeito eu desabo
- tomei a mais porque precisava render

O que observar em sessão

Mais organização no discurso, menor dispersão, maior capacidade de cumprir combinados, mas também irritabilidade, aceleração, ansiedade corporal, redução de apetite, insônia, tiques, pressão por desempenho e uso da medicação como solução para excesso de demanda.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Produtividade pode parecer melhora global mesmo quando sono e corpo pioraram. Ansiedade induzida ou intensificada pode parecer piora do transtorno ansioso. Insônia pode agravar humor e impulsividade. Uso fora da prescrição pode parecer "comprometimento com melhora", mas exige cuidado clínico e médico.

Perguntas úteis

- Você percebe mais foco ou mais aceleração?
- Como ficaram sono, apetite e irritabilidade?
- Quando o efeito passa, o que acontece?
- Você já tomou diferente do combinado com o médico?
- Alguém já pediu seu remédio emprestado?
- A melhora está ajudando sua vida ou só aumentando sua exigência consigo?

Amarelo: alinhar em breve

- Insônia persistente
- ansiedade ou irritabilidade novas
- perda de apetite ou peso
- palpitações
- tiques
- piora de impulsividade
- uso diferente da prescrição
- uso para desempenho sem indicação clara
- queda importante quando o efeito passa
- suspeita de mistura com álcool ou outras substâncias

Vermelho: tratar como urgência

- Dor no peito
- desmaio
- palpitações intensas
- agitação grave
- sintomas psicóticos
- sintomas maniformes
- ideação suicida
- uso excessivo ou impulsivo
- comportamento de risco
- ereção dolorosa ou prolongada relatada pelo paciente

Frase clínica

"O foco melhorou, mas o corpo começou a pagar a conta."

Cuidado ético

Observe o impacto em sono, apetite, ansiedade, vínculo e rotina. Sinais de uso irregular ou fora do padrão prescrito merecem comunicação com o psiquiatra.

05 SERTRALINA

ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Na linguagem da sessão: antidepressivo muito comum para ansiedade e humor.

Nome

Sertralina. Também aparece como cloridrato de sertralina. Nomes comerciais muito conhecidos: Zoloft, Tolrest, Serenata.

Uso comum

Depressão, transtorno do pânico, ansiedade social, TOC, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e TPM severa.

O paciente pode relatar

- Estou lidando melhor com meus medos
- parece que as coisas não me afetam tanto
- tenho tido dor de barriga ou queimação
- minha libido diminuiu bastante
- minha ansiedade piorou nos primeiros dias

O que observar em sessão

Menos labilidade emocional, maior tolerância à exposição (ótimo para pânico e TOC), mas também possível inquietação nos primeiros dias, diminuição do desejo sexual ou queixas gastrointestinais que o incomodam.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A piora inicial da ansiedade nas primeiras duas semanas pode parecer que "o remédio fez mal" ou resistência. O afeto mais "reto" (embotamento leve) pode parecer que o paciente não liga mais para a própria vida, mascarando empatia.

Perguntas úteis

- A queimação no estômago ou diarreia começaram junto com o remédio?
- Como ficou sua vontade de se relacionar sexualmente?
- Sentiu mais agitação física no começo?
- O choro parou porque a dor passou, ou porque você não consegue chorar mesmo querendo?

Amarelo: alinhar em breve

- Efeitos gastrointestinais persistentes (intolerância gástrica)
- apatia forte
- disfunção sexual que causa sofrimento relacional
- ansiedade paradoxal forte e persistente
- abandono por conta dos efeitos colaterais

Vermelho: tratar como urgência

- Ideação suicida nova ou intensificada na fase inicial de ativação (o paciente ganha energia antes de ganhar humor)
- virada maníaca (aceleração forte do pensamento)
- menos necessidade de sono)

Frase clínica

"As obsessões diminuíram o volume, mas a digestão e a libido sentiram o baque."

Cuidado ético

Não sugira que a dor de estômago ou falta de libido "são fundo emocional", pois são efeitos adversos reais e comuns. Organize o relato para ele levar ao médico.

06 FLUOXETINA

ISRS. Na linguagem clínica: antidepressivo com perfil frequentemente mais "ativador" ou energizante, de eliminação muito lenta.

Nome

Fluoxetina. Também cloridrato de fluoxetina. Nomes comerciais comuns: Prozac, Daforin, Verotina.

Uso comum

Depressão (especialmente com lentificação), bulimia nervosa, TOC, transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM).

O paciente pode relatar

- Tô com mais energia pra sair da cama
- perdi um pouco a fome
- tô meio elétrico ou inquieto
- não consigo dormir direito se tomar à tarde
- meus episódios de comer demais diminuíram

O que observar em sessão

Maior ativação motora, melhora do retardo psicomotor típico da depressão melancólica, redução de episódios de compulsão alimentar, mas também possível insônia, tremor fino e aceleração verbal.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A energia aumentada pode parecer melhora, mas se vier com insônia, a irritabilidade vai piorar logo depois. Pode ser confundida com piora da ansiedade de base ou desencadear quadros acelerados difíceis de frear.

Perguntas úteis

- Que horas você está tomando a medicação?
- Sentiu que sua energia aumentou, mas o corpo continua tenso?
- A compulsão alimentar diminuiu?
- Está com dificuldade para pegar no sono à noite?

Amarelo: alinhar em breve

- Insônia persistente
- agitação motora ou ansiedade exacerbada que não passa
- perda de peso severa indesejada
- tremores finos que atrapalham rotina

Vermelho: tratar como urgência

- Aceleração aguda e intensa do pensamento e do corpo (mania)
- agressividade atípica
- ideação suicida no começo do tratamento
- sinais de síndrome serotoninérgica

Frase clínica

"Tirou a pessoa da cama com mais energia, mas às vezes esquece de deixar ela dormir à noite."

Cuidado ético

Como a fluoxetina fica semanas no organismo mesmo após suspensão, não sugira "parar uns dias para ver se o sono volta". Toda alteração exige paciência metabólica e manejo médico.

07 ALPRAZOLAM

Benzodiazepínico. Na linguagem da sessão: calmante de ação muito rápida e curta, alto poder ansiolítico.

Nome

Alprazolam. Nome comercial muito conhecido: Frontal, Apraz.

Uso comum

Crises agudas de ansiedade, ataques de pânico.

O paciente pode relatar

- Faz efeito super rápido na hora do sufoco
- quando passa o efeito, a ansiedade volta mais forte
- ando meio esquecido
- preciso carregar ele na bolsa por garantia, senão entro em pânico

O que observar em sessão

Alívio muito veloz do pico de ansiedade, mas presença de ansiedade de rebote (sofrimento sobre rápido entre uma dose e outra), amnésia para fatos recentes da sessão, dependência psicológica (medicamento vira "objeto contrafóbico").

Efeitos que confundem a leitura clínica

A piora da ansiedade no meio do dia pode não ser agravamento do quadro original, mas sim "ansiedade de rebote" provocada pela meia-vida curta (o corpo sentindo a falta repentina). Parecer esquecido pode ser lido como desatenção.

Perguntas úteis

- A ansiedade ataca nos horários em que o remédio está perdendo o efeito?
- Você sente necessidade de antecipar a dose?
- Lembra do principal que conversamos na sessão passada?
- O que acontece se você sair e esquecer o remédio em casa?

Amarelo: alinhar em breve

- Uso em doses crescentes
- paciente sentindo montanha-russa emocional no mesmo dia (rebote)
- queixa persistente de falha de memória
- uso impulsivo para qualquer emoção negativa leve

Vermelho: tratar como urgência

- Quedas (especialmente idosos)
- mistura com álcool (depressão respiratória grave)
- tentativa do paciente de parar de vez por conta própria (risco real de abstinência e convulsão)

Frase clínica

"Apaga o incêndio muito rápido, mas o fogo volta mais alto horas depois, e a memória fica na fumaça."

Cuidado ético

A cartela na bolsa pode funcionar como objeto contrafóbico. Sugerir a retirada sem manejo gradual pode intensificar o pânico. Alinhe com o psiquiatra o timing adequado.

08 DIAZEPAM

Benzodiazepínico. Na linguagem clínica: calmante, relaxante muscular e anticonvulsivante de ação e permanência muito longas no corpo.

Nome

Diazepam. Nome comercial histórico: Valium, Dienpax.

Uso comum

Ansiedade generalizada forte, espasmos e tensões musculares, síndromes de abstinência alcoólica, e pacientes antigos em uso crônico.

O paciente pode relatar

- Fico meio morgado o dia todo
- minhas costas e o corpo relaxaram muito
- durmo à noite, mas acordo de ressaca e pesado
- tomo essa pílula amarelinha há 15 anos

O que observar em sessão

Lentificação motora e cognitiva contínua, postura fisicamente relaxada (menos tônus), sonolência prolongada tipo "ressaca" (efeito residual no dia seguinte), discurso mais arrastado, e muitas vezes um apego inegociável ao uso diário contínuo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A sedação constante pode ser lida como depressão refratária, apatia ou "falta de energia vital". Na verdade, pode ser o acúmulo da medicação, já que ela tem metabólitos ativos que ficam muitos dias no corpo.

Perguntas úteis

- Você acorda sentindo uma ressaca ou peso na cabeça?
- Sente os músculos muito moles ou fraqueza nas pernas?
- Há quantos anos você faz uso contínuo?
- O seu tempo de reação no trânsito ou no trabalho piorou?

Amarelo: alinhar em breve

- Pacientes idosos usando cronicamente (risco imenso de queda e confusão mental silenciosa)
- sonolência diurna excessiva
- paciente tentando aumentar dose sem avisar

Vermelho: tratar como urgência

- Sedação excessiva impedindo o despertar
- mistura consciente com grandes quantidades de álcool
- falta de coordenação grave (ataxia)

Frase clínica

"A ansiedade dormiu, mas o corpo ficou pesado e a mente arrastada dia sim, dia não."

Cuidado ético

Não julgue ou demonize o "uso contínuo há 20 anos". O desmame de um diazepam usado cronicamente é uma intervenção médica delicadíssima e demorada.

09 RISPERIDONA

Antipsicótico atípico. Na linguagem clínica: organizador profundo do pensamento e freio potente de impulsividade, agitação e psicose.

Nome

Risperidona. Nome comercial conhecido: Risperdal.

Uso comum

Esquizofrenia, transtorno bipolar, controle de agitação grave e autolesão, irritabilidade em TEA (Autismo).

O paciente pode relatar

- A barulheira na minha cabeça parou
- sinto meu corpo meio travado
- engordei
- minha menstruação desregulou toda
- surgiu leite no meu peito (mulheres)
- tenho uma agonia sem fim nas pernas

O que observar em sessão

Controle impressionante de delírios, alucinações ou agressividade. Porém, pode surgir rigidez corporal, rosto "sem expressão" (fácies em máscara), ganho de peso, lentidão e uma inquietação motora onde o paciente não consegue ficar parado sentado.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O rosto sem emoção (fácies em máscara) pode parecer "frieza", "falta de empatia" ou "depressão grave". A inquietação desesperadora nas pernas (acatisia) é frequentemente confundida com "piora violenta da ansiedade" ou crise de pânico.

Perguntas úteis

- Você está sentindo os músculos duros, como se estivesse engessado?
- Tem uma inquietação insuportável nas pernas, vontade de ficar andando?
- Notou mudança no peso, atraso na menstruação ou sensibilidade na mama?

Amarelo: alinhar em breve

- Inquietação persistente (acatisia)
- tremores nas mãos
- corpo travado afetando rotina
- aumento de mamas ou saída de leite (galactorreia)
- alerta de aumento de prolactina)
- ganho de peso relevante

Vermelho: tratar como urgência

- Febre alta associada a rigidez severa e confusão mental (Sinal de Síndrome Neuroléptica Maligna)
- emergência grave!)
- movimentos musculares involuntários de língua ou pescoço

Frase clínica

"O pensamento alinhou e acalmou, mas o corpo travou e o metabolismo desregulou."

Cuidado ético

Se observar "ansiedade física nas pernas" onde o paciente não consegue ficar sentado (acatisia), não trate isso com "técnicas de respiração". É um sofrimento neurológico medicamentoso; encaminhe para o médico agir na prescrição.

10 OLANZAPINA

Antipsicótico atípico. Na linguagem clínica: estabilizador potente, muito sedativo e freio radical para episódios agudos de elevação e agressividade.

Nome

Olanzapina. Nome comercial muito conhecido: Zyprexa.

Uso comum

Transtorno bipolar (fase de mania ou manutenção forte), esquizofrenia, agitação grave, depressões resistentes específicas.

O paciente pode relatar

- Eu apago e durmo 12 horas seguidas
- nunca tive tanta fome na minha vida, devoro carboidrato
- engordei 10 kg em um mês e tô desesperado com isso
- minha mania sumiu

O que observar em sessão

Excelente controle rápido de quadros de mania e agitação desorganizada. Mas vem com sedação extrema, letargia aparente ("preguiça" profunda) e ganho de peso acelerado. O desespero corporal do paciente fica óbvio.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O sono prolongado pode parecer comportamento evasivo, fuga, "sintoma negativo" de esquizofrenia ou depressão. O intenso ganho de peso gera uma crise de autoestima e vergonha que o paciente culpa na terapia ou abandona a medicação em segredo.

Perguntas úteis

- Você consegue acordar a tempo para suas responsabilidades ou o remédio te prende na cama?
- A fome intensa acontece mais à noite?
- O ganho de peso está fazendo você pensar em parar o remédio por conta própria?

Amarelo: alinhar em breve

- Ganho de peso rápido e forte (risco metabólico é a regra aqui)
- sedação diurna incapacitante
- exames apontando aumento brusco de colesterol e glicemia (açúcar)

Vermelho: tratar como urgência

- Quedas ou desmaios ao levantar
- confusão extrema
- sinais de hiperglicemia aguda (muitíssima sede
- muita urina)
- ou intenção de abandono letal

Frase clínica

"Cortou a mania pela raiz como um machado, mas trouxe um sono de pedra e uma fome incontrolável por doce."

Cuidado ético

Não reduza o aumento de peso a "falta de força de vontade" ou "compulsão emocional". O impulso alimentar induzido pela olanzapina é um roubo metabólico fortíssimo. Apoie a conversa do paciente com o psiquiatra.

11 ARIPIPAZOL

Antipsicótico atípico. Na linguagem clínica: modulador de humor mais "limpo" metabolicamente, pouco sedativo, que tende a ativar mais do que derrubar.

Nome

Aripiprazol. Nomes comerciais comuns: Aristab, Abilify.

Uso comum

Transtorno bipolar, esquizofrenia, irritabilidade no autismo e usado em dose baixa como acelerador de antidepressivos em quadros depressivos teimosos.

O paciente pode relatar

- Não engordei nem fiquei dopado como em outros remédios
- tô agitado, sinto um formigamento dentro das pernas
- meu humor firmou
- ando com vontade louca de gastar no shopping ou jogar

O que observar em sessão

Preservação do peso, menor letargia. Boa melhora no afeto e humor. Porém, a observação crítica é notar o paciente balançando a perna o tempo todo (acatisia) e relatar perda do freio de impulsos (compras impulsivas e compulsão sexual atípica para ele).

Efeitos que confundem a leitura clínica

A agitação física da acatisia é quase idêntica à de um ataque de pânico severo se o terapeuta não estiver atento. A perda de controle de impulsos (jogo, sexo, compras) pode ser lida erradamente como "virada para Mania do transtorno Bipolar", quando pode ser puramente induzida pelo remédio (efeito raro, mas notório).

Perguntas úteis

- Essa agitação é preocupação mental ou é uma agonia física nos músculos que te obriga a se mexer?
- Você notou impulsos compulsivos recentes por jogo, pornografia, compras, que não são da sua personalidade?
- Sente-se mais 'aceso' à noite?

Amarelo: alinhar em breve

- Relato de acatisia (agonia nas pernas)
- perda de freio moral e financeiro (compulsão por jogo)
- compras ou sexo de risco)
- insônia contínua

Vermelho: tratar como urgência

- Acatisia que se torna insuportável gerando ideação suicida abrupta de fuga (frequente em acatisia grave)
- impulsos que colocam o paciente ou a família em risco de ruína financeira ou física imediata

Frase clínica

"Salvou o paciente do ganho de peso e do sono, mas pode ter acendido uma fogueira de agitação nas pernas e nos impulsos."

Cuidado ético

O controle de impulsos perdido com aripiprazol não responde bem à psicoterapia focada em autocontrole; ele responde à retirada/ajuste médico da dose. Não sobrecarregue o paciente com culpa.

12 LISDEXANFETAMINA

Estimulante do sistema nervoso central (pró-fármaco). Na linguagem clínica: medicamento para déficit de atenção e hiperatividade.

Nome

Lisdexanfetamina. Dimesilato de lisdexanfetamina. Nome comercial forte: Venvanse, Juneve, Lyberdia.

Uso comum

TDAH (aumentar foco, diminuir procrastinação) e Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica.

O paciente pode relatar

- Meu foco parece um laser o dia todo
- minha compulsão por doce desapareceu de dia
- fico super irritado lá pelas 18h
- ando obcecado com os detalhes do trabalho
- sem ele eu não existo

O que observar em sessão

Discurso mais rápido e concatenado, foco prolongado. Perda de apetite evidente de dia. Presença de "hiperfoco" alienante. Tensão na mandíbula (bruxismo). Efeito rebote dramático no fim da tarde/noite com exaustão pesada e intolerância frustração.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O paciente rende muito no trabalho e você comemora o fim da procrastinação, mas a família relata que ele ficou grosso, seco e explosivo à noite (o "crash" da medicação). A perda de peso pode ser celebrada, mas o paciente pode estar desnutrido.

Perguntas úteis

- O que acontece depois das 18h, quando o efeito começa a apagar?
- Você tem conseguido forçar o almoço mesmo sem fome?
- Está sentindo o maxilar mais tenso ou dolorido?
- Como fica o seu humor quando você não toma aos finais de semana?

Amarelo: alinhar em breve

- Irritabilidade severa no "crash" da tarde
- insônia rebelde à noite
- tiques motores novos
- comportamento dependente ("estou dobrando a dose para trabalhar até mais tarde")
- perda brutal de peso

Vermelho: tratar como urgência

- Sinais de psicose aguda
- delírios persecutórios ou mania induzida
- picos de hipertensão arterial ou taquicardia forte
- ideação suicida pesada no período de queda da droga (fim da tarde)

Frase clínica

"Garante um dia útil de alta performance, mas rouba o jantar, a empatia noturna e tenciona o corpo."

Cuidado ético

Práticas fora do prescrito (diluir, fracionar a dose, abrir a cápsula) envolvem riscos sérios. Se o paciente mencionar, encaminhe ao psiquiatra.

13 LÍTIO

Estabilizador de humor (o padrão-ouro).

Nome

Lítio. Carbonato de lítio. Nomes comerciais comuns: Carbolitium.

Uso comum

Transtorno Bipolar (mania aguda e manutenção preventiva), potencialização de depressões muito resistentes, redução de risco de suicídio.

O paciente pode relatar

- Tenho uma sede que não passa
- faço muito xixi
- minhas mãos estão tremendo
- sinto um gosto metálico na boca
- fiquei com a mente meio enevoadada (brain fog)
- minha acne piorou

O que observar em sessão

Excelente proteção contra oscilações de humor. Aumento expressivo do consumo de água durante a sessão. Tremor fino e rápido nas mãos. Um afeto que parece mais "plano", como se a vida tivesse perdido um pouco da emoção intensa.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A queixa de "estou sem energia criativa" ou "a vida perdeu a graça" é frequente em bipolares estabilizados pelo lítio. O paciente sente falta da euforia da hipomania e culpa o remédio de causar "depressão" ou "apatia".

Perguntas úteis

- O tremor nas mãos atrapalha para escrever ou usar o celular?
- Você está fazendo exame de sangue regular (litemia)?
- Sentiu muita náusea ou diarreia ultimamente?
- Você acha que a vida perdeu a graça ou apenas perdeu a aceleração?

Amarelo: alinhar em breve

- Tremor nas mãos limitante
- náuseas e vômitos constantes
- queixa forte de letargia cognitiva
- paciente relatando que parou o remédio de vez porque sentia saudade da energia de antes

Vermelho: tratar como urgência

- Tremores muito fortes no corpo todo
- fala arrastada
- confusão mental severa
- andar cambaleante
- diarreia profusa (todos são sinais clássicos de Intoxicação por Lítio)
- emergência médica!)

Frase clínica

"Estabiliza o humor maravilhosamente, mas o paciente pede água o tempo todo e reclama que a vida perdeu a emoção."

Cuidado ético

O Lítio exige nível muito exato no sangue (janela terapêutica estreita). Se o paciente tiver sudorese extrema (maratona/sauna) ou diarreia severa, o lítio concentra no sangue e intoxica. Alerte para falar com o médico.

14 LAMOTRIGINA

Estabilizador de humor e anticonvulsivante. Na linguagem clínica: protetor contra fases depressivas.

Nome

Lamotrigina. Nomes comerciais comuns: Lamictal, Neural.

Uso comum

Transtorno Bipolar (especialmente para prevenir depressão bipolar), convulsões.

O paciente pode relatar

- Sinto que os altos e baixos pararam
- parece que demora mais pra fazer efeito que os outros
- notei umas manchas vermelhas no corpo
- sinto tontura de leve

O que observar em sessão

Estabilização mais lenta, sem a sedação pesada do lítio ou olanzapina. Paciente mais funcional, acordado e com peso estável. Porém, queixas de erupções na pele são o grande alerta de atenção.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Como o aumento da dose precisa ser hiper-lento (para evitar alergia grave), o paciente pode achar que a medicação "não está funcionando" nas primeiras semanas e desistir.

Perguntas úteis

- Apareceu alguma irritação, coceira ou mancha vermelha na pele, nas mucosas ou ao redor dos olhos?
- Como está a paciência para o aumento lento da dose?

Amarelo: alinhar em breve

- Qualquer
- repito
- qualquer surgimento de mancha vermelha na pele no início do tratamento. Insônia resistente
- relato de que a depressão piorou na fase de introdução

Vermelho: tratar como urgência

- Manchas vermelhas que descamam
- associadas a febre
- feridas na boca ou olhos (Risco de Síndrome de Stevens-Johnson)
- emergência cutânea grave e letal)

Frase clínica

"Protege muito contra o polo depressivo sem dopar, mas exige paciência e fiscalização diária da pele."

Cuidado ético

A atenção à pele é mandatória. Não menospreze se o paciente disser "deu uma alergia aqui no pescoço". Mande fotografar e enviar ao médico imediatamente.

15 VALPROATO (ÁCIDO VALPROICO)

Estabilizador de humor e anticonvulsivante. Na linguagem clínica: freio potente para mania e irritabilidade grave.

Nome

Ácido valproico ou Valproato de Sódio ou Divalproato de Sódio. Nomes: Depakote, Depakene, Torval.

Uso comum

Transtorno Bipolar (mania), epilepsia, prevenção de enxaqueca, impulsividade crônica severa.

O paciente pode relatar

- Meu pavio ficou muito mais longo
- engordei rápido
- meu cabelo está caindo
- meu estômago dói quando tomo
- minhas mãos tremem

O que observar em sessão

Excelente redução de explosões de raiva. Porém, comumente se observa queixa de aumento de peso, tremor leve e, em mulheres, queixa de queda de cabelo e possível aumento de pelos ou desregulação do ciclo menstrual.

Efeitos que confundem a leitura clínica

As alterações físicas e capilares em mulheres podem gerar uma angústia severa de autoimagem, que vai dominar as sessões e desviar do problema inicial psiquiátrico.

Perguntas úteis

- O seu humor estabilizou à custa de muito ganho de peso?
- Você sentiu muito enjoo?
- Se for mulher: houve alguma mudança no seu ciclo menstrual ou cabelo?

Amarelo: alinhar em breve

- Ganho de peso que gere risco de abandono do tratamento
- queda de cabelo acentuada
- tremores intensos nas mãos
- sintomas ováricos (SOP)

Vermelho: tratar como urgência

- Icterícia (olhos e pele amarelos)
- dor abdominal intensa e vômito severo (risco de hepatite ou pancreatite induzida)
- sonolência profunda anormal
- risco fetal altíssimo se houver gravidez surpresa

Frase clínica

"Aumenta a paciência de forma brutal, mas agride o estômago, o peso e os fios de cabelo."

Cuidado ético

Se a paciente engravidar enquanto toma Valproato, é urgência psiquiátrica e obstétrica devido ao altíssimo risco de malformação do feto.

16 BUPROPIONA

Antidepressivo (inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina - IRND). Na linguagem clínica: antidepressivo estimulante sem danos sexuais.

Nome

Bupropiona. Nomes comerciais comuns: Wellbutrin, Bup, Zetron.

Uso comum

Depressão com fadiga e letargia, cessação de tabagismo, potencializador de libido perdida por ISRS, TDAH (off-label).

O paciente pode relatar

- Tô com muito mais foco
- parei de fumar fácil
- minha vontade de fazer sexo voltou
- tô ansioso pra caramba
- minha boca tá muito seca
- ando irritado, pareço elétrico

O que observar em sessão

Aumento vibrante de energia e iniciativa. É o antidepressivo "fácil de gostar" por não dar sono, não engordar e melhorar o sexo. Mas observe aumento óbvio de ansiedade, tensão e possivelmente suor excessivo.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Se o paciente já era ansioso de base, a bupropiona pode jogar gasolina no pânico. Ele melhora da tristeza, mas vira uma pilha de nervos. Pode piorar insônia se tomado muito tarde.

Perguntas úteis

- Aumentou muito sua ansiedade corporal?
- Como está seu sono?
- Você sentiu que sua irritabilidade aumentou à toa?
- Sente zumbido no ouvido?

Amarelo: alinhar em breve

- Piora pesada de ansiedade
- ataque de pânico induzido
- irritabilidade hostil
- insônia resistente severa

Vermelho: tratar como urgência

- Convulsões agudas (a bupropiona baixa o limiar convulsivo)
- descontrole maníaco agressivo

Frase clínica

"Devolve energia e libido rápido, mas frequentemente transforma o triste e cansado no ansioso e irritado."

Cuidado ético

Preste muita atenção ao uso abusivo. Em pacientes com histórico de transtorno alimentar crônico (anorexia/bulimia forte), o risco de convulsão pela bupropiona é alto.

17 MIRTAZAPINA

Antidepressivo tetracíclico. Na linguagem clínica: antidepressivo altamente sedativo e estimulador de apetite (não causa dano sexual).

Nome

Mirtazapina. Nomes comerciais comuns: Remeron, Menelat.

Uso comum

Depressão severa acompanhada de insônia profunda e perda de peso acentuada.

O paciente pode relatar

- Durmo muito bem, um sono pesado
- nunca comi tanto carboidrato na vida
- engordei muito rápido
- minha depressão melhorou

O que observar em sessão

Resolução mágica da insônia logo nas primeiras semanas e um humor mais responsivo. Mas é notório o peso crescente. O paciente costuma apresentar letargia e aumento de massa nas consultas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Curiosamente, na Mirtazapina, as doses mais baixas (15mg) dão MAIS SONO e mais fome do que as doses altas (30mg, 45mg). O paciente pode achar que diminuir a dose vai ajudar na "morgueza", mas vai piorar o sono.

Perguntas úteis

- A fome por doces ou massa à noite ficou descontrolada?
- Você está demorando muito para engrenar de manhã por causa do sono residual?
- O ganho de peso afeta sua adesão ao remédio?

Amarelo: alinhar em breve

- Sobrepeso que gera muito sofrimento ou dano metabólico real
- sedação diurna brutal ("ressaca" pesada)

Vermelho: tratar como urgência

- Reações alérgicas ou infecções não explicáveis graves associadas à queda de leucócitos (efeito super raro)
- mas existe)

Frase clínica

"O remédio que apaga a insônia mais teimosa, mas cobra o preço abrindo a porta da geladeira à noite."

Cuidado ético

Não desvalide o "eu não consigo parar de comer". O estímulo nos receptores de histamina é fisiológico. A mirtazapina é espetacular para pacientes idosos deprimidos que não comem e não dormem.

18 TRAZODONA

Antidepressivo SARI. Na linguagem clínica: o "antidepressivo que o psiquiatra usa em dose baixa para fazer você dormir".

Nome

Trazodona. Cloridrato de trazodona. Nomes comerciais: Donaren.

Uso comum

Insônia com depressão/ansiedade (dose baixa 50-150mg). Antidepressivo real só em doses altas (acima de 150-300mg).

O paciente pode relatar

- Durmo a noite toda sem viciar
- sinto uma tontura quando acordo de madrugada pra ir ao banheiro
- meu nariz parece que entope quando tomo
- engrossei a voz ou acordei estufado

O que observar em sessão

Excelente transição suave para um sono de qualidade sem a dependência do Rivotril ou Zolpidem. O paciente não engorda. Costuma relatar leve tontura postural ou nariz entupido leve de noite.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O paciente pode estar "deprimido", tomando Trazodona 50mg, e dizendo que o "antidepressivo não faz efeito na tristeza". Essa dose só faz efeito no sono.

Perguntas úteis

- O sono induzido é reparador ou deixa muita ressaca?
- Sente tontura forte ao levantar da cama de noite?
- Homens: sentiram ereção anormal ou dolorida de noite/manhã?

Amarelo: alinhar em breve

- Tonturas frequentes e risco de queda ao levantar de madrugada (especialmente perigoso em idosos)

Vermelho: tratar como urgência

- Ereção dolorosa persistente e longa em homens que não baixa (Priapismo)
- efeito raríssimo
- mas emergência urológica imediata
- pode necrosar o pênis)

Frase clínica

"O sonífero psiquiátrico de eleição para sair dos tarja preta, quase sem efeitos colaterais fortes, a não ser a tontura na madrugada."

Cuidado ético

O cuidado é investigar se a ansiedade está piorando no meio do dia, pois a ação calmante de doses baixas de trazodona não cobre as 24h.

19 VENLAFAXINA (E DULOXETINA)

Duais. Inibidores da recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN).

Nome

Venlafaxina (Efexor, Venlift) / Duloxetina (Cymbalta, Velija).

Uso comum

Depressões pesadas, ansiedade generalizada persistente e tratamento de dores crônicas (Duloxetina é mestre da dor).

O paciente pode relatar

- Deu um empurrão que a Sertralina não dava
- minhas dores no corpo melhoraram muito
- transpiro demais de noite, suor nas costas
- se atraso a dose 2 horas, sinto minha cabeça dar choque
- estou muito enjoado

O que observar em sessão

Muita energia devolvida. Menos lentidão. Se o paciente for portador de Fibromialgia, a melhora com a Duloxetina é notável. Porém, transpiram excessivamente ("suores noturnos") e sofrem abusivamente com abstinência.

Efeitos que confundem a leitura clínica

Os "choques na cabeça" (brain zaps) ou tontura extrema que o paciente relata não são volta do pânico, e sim abstinência violenta gerada por atrasar uma simples dose em poucas horas (síndrome de descontinuação rápida).

Perguntas úteis

- Você costuma esquecer de tomar a cápsula no horário certo?
- Sentiu que começou a transpirar demais?
- Mediu a pressão arterial nos primeiros dias?

Amarelo: alinhar em breve

- Suor noturno extremo que afeta qualidade de vida
- aumento de pressão arterial que não estabiliza
- paciente assustado com efeitos de esquecer a dose

Vermelho: tratar como urgência

- Sinais cardiovasculares descontrolados
- síndrome serotoninérgica
- ideação suicida forte

Frase clínica

"Ação de tanque de guerra na dor e tristeza, mas cobra fidelidade horária implacável senão os choques de abstinência punem."

Cuidado ético

Na tentativa de parar venlafaxina ou duloxetina, o desmame exige semanas ou meses e o paciente sofre muito. Seja a rocha de validação da dor física que ele sentirá ("brain zaps", enjoo, tonteira, choro fácil).

20 BUSPIRONA

Ansiolítico (Azapirona). Na linguagem clínica: ansiolítico que não causa vício, sedação e não altera a memória (o "antípoda" dos benzodiazepínicos).

Nome

Buspirona. Cloridrato de Buspirona. Nomes comerciais: Ansitec, Buspanil.

Uso comum

Ansiedade generalizada crônica, quadros ansiogênicos leves e contínuos.

O paciente pode relatar

- Sinto que não está fazendo efeito nenhum
- dá uma dor de cabeça esquisita logo que tomo
- sinto uma tontura boba
- meu sono não mudou

O que observar em sessão

Redução gradual, lenta e sutil da ansiedade corporal. Não há sedação visível, não há relaxamento muscular imediato. O paciente segue absolutamente funcional.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O paciente frequentemente acusa "o remédio de ser água" ou "estar fraco demais", especialmente se ele foi usuário prévio de Rivotril/Alprazolam e espera a "pancada sedativa" para achar que a ansiedade melhorou.

Perguntas úteis

- Você está sentindo tontura rotatória nos primeiros dias?
- Qual a sua expectativa de velocidade com esse remédio em comparação ao antigo?
- Como está a ansiedade de fundo ao longo das semanas?

Amarelo: alinhar em breve

- Tonturas incapacitantes
- irritabilidade paradoxal extrema
- queixa crônica de que o remédio não surtiu efeito após 4 semanas (pede reavaliação médica)

Vermelho: tratar como urgência

- Relatos de episódios confusos súbitos
- febre inexplicável ou dores musculares (se misturado inadvertidamente com inibidores da MAO ou grandes quantidades de suco de toranja)

Frase clínica

"O ansiolítico mais leve e paciente, que trabalha nos bastidores frustrando quem buscava alívio fulminante."

Cuidado ético

Cuidado ao endossar a reclamação do paciente de que "o remédio não funciona". É responsabilidade nossa explicar (e reforçar a psicoeducação do médico) que a ausência de pancada sedativa é justamente a vantagem orgânica da Buspirona.

21 PREGABALINA

Anticonvulsivante (neuromodulador). Na linguagem clínica: protetor da dor neuropática severa e regulador de grandes ansiedades.

Nome

Pregabalina. Nomes comerciais comuns: Lyrica, Prebictal.

Uso comum

Dores crônicas neuropáticas, fibromialgia fortíssima, Transtorno de Ansiedade Generalizada resistente a outras abordagens.

O paciente pode relatar

- Minhas dores sumiram ou acalmaram como num milagre
- sinto minha visão meio embaçada ou tonta no início
- minhas pernas estão inchando
- ando esquecido e aéreo

O que observar em sessão

Alívio da tensão muscular gerada pela ansiedade e pela dor crônica. Maior fluidez de discurso (se a dor inibia o pensar). Mas observe ganho de peso progressivo por inchaço (edema) e letargia perceptível.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A pregabalina gera dependência cruzada e forte apego emocional em alguns pacientes, levando a relatos exagerados de piora apenas para conseguir aumento da dose. O letargia mental pode parecer embotamento depressivo.

Perguntas úteis

- O seu sapato está mais apertado no final do dia (inchaço)?
- O que você sente quando atrasa a dose?
- Percebeu ganho de peso não associado à comida?
- Sua coordenação motora ou equilíbrio mudaram?

Amarelo: alinhar em breve

- Paciente ganhando muito peso através de inchaço aparente severo (edema)
- desequilíbrio perigoso (ataxia)
- risco de abuso em pacientes com histórico de drogadição
- depressão respiratória se associada a álcool pesadamente

Vermelho: tratar como urgência

- Dificuldade respiratória importante
- confusão mental intensa ou delirium. Ideação suicida acentuada
- inchaço subitamente excessivo de todo o corpo ou do rosto (alergia severa)

Frase clínica

"Apaga o incêndio da dor no nervo, mas incha os pés e deixa a mente navegando por um nevoeiro."

Cuidado ético

É perigoso sugerir retirada abrupta da Pregabalina por causa dos inchaços ou tonturas sem anuência médica rigorosa. A síndrome de abstinência é muito pesada (insônia grave, ansiedade intensa, até convulsão).

22 CARBAMAZEPINA

Anticonvulsivante / Estabilizador de humor.

Nome

Carbamazepina. Nome comercial principal: Tegretol.

Uso comum

Epilepsia, dores nevralgias (nervo trigêmeo), manutenção/estabilização no Transtorno Bipolar, dependência alcoólica agudizada.

O paciente pode relatar

- Sinto visão dupla de vez em quando
- estou muito enjoado
- apareceram umas manchas estranhas no corpo e não sei por quê
- meu outro remédio parou de fazer efeito do nada

O que observar em sessão

Redução de agressividade orgânica e regulação boa de humor em bipolares. Mas é a medicação "rainha" das interações no fígado (ela destrói o efeito de outros remédios). Muito cuidado com sedação repentina, náusea aparente e vermelhidões.

Efeitos que confundem a leitura clínica

"Eu tomo anticoncepcional e fiquei grávida" (a carbamazepina anula várias pílulas hormonais). Pode parecer displicência do paciente, mas é roubo farmacológico metabólico. A tontura/vertigem pode ser lida como somatização.

Perguntas úteis

- Seus médicos todos sabem que você usa Tegretol? Isso é crítico.
- Sentiu manchas no corpo, dor na garganta não explicável, ou sangramentos fáceis na gengiva?
- Notou visão embaçada, visão dupla ou tontura forte?

Amarelo: alinhar em breve

- Sintomas estranhos em uso combinado com outros remédios de ansiedade (a carbamazepina acelera a quebra de outros remédios)
- deixando-os ineficazes)
- queixa de falha de proteção hormonal. Aparecimento de infecções constantes na boca

Vermelho: tratar como urgência

- Lesões vermelhas descamativas severas pelo corpo
- inchaço em linfonodos (ínguas)
- confusão mental por hiponatremia aguda (baixa de sódio grave)
- especialmente em idosos com confusão)
- febres sem causa

Frase clínica

"Estabiliza o caos cerebral agressivamente, mas devora no fígado a eficácia das outras drogas que chegam."

Cuidado ético

O cuidado aqui é atuar como "agente de rede". Toda e qualquer nova pílula prescrita ou tomada por este paciente precisa passar pelo conhecimento do psiquiatra principal.

23 HALOPERIDOL

Antipsicótico típico de Primeira Geração ("Clássico"). O mais famoso antipsicótico antigo.

Nome

Haloperidol. Nomes comerciais comuns: Haldol.

Uso comum

Surto psicóticos agudos, esquizofrenia violenta grave, episódios maníacos agressivos com perda total de juízo, agitação em delírium, tiques crônicos (como Síndrome de Tourette).

O paciente pode relatar

- Não tenho mais pensamentos
- estou engessado, duro como tábua
- minha mandíbula entortou sozinha ontem
- eu babo sem querer
- não consigo ficar parado na cadeira

O que observar em sessão

Desligamento frontal forte de vozes e delírios, mas um custo motor violento ("impregnação"). O paciente treme (parkinsonismo), tem marcha robótica de passos curtos, rosto hiper-rígido sem expressão, agitação nas pernas.

Efeitos que confundem a leitura clínica

A total inexpressão facial gerada pelo haloperidol é frequentemente confundida com o "embotamento natural da esquizofrenia" (sintomas negativos). O desespero motriz das pernas (acatisia) é confundido com exacerbação de mania ou pânico violento (gera sofrimento insuportável).

Perguntas úteis

- A inquietude está nos seus músculos, puxando as pernas?
- Sente câibras musculares no pescoço ou nos olhos virando para cima?
- O tremor nas mãos te impede de segurar copo ou garfo?

Amarelo: alinhar em breve

- Rigidez motora de marcha
- tremores das mãos evidentes (pedir para ele usar medicações como Biperideno [Akineton] em conjunto é praxe)
- acatisia
- aumento de peito/leite (galactorreia fortíssima pelo aumento intenso de prolactina)

Vermelho: tratar como urgência

- Distonia aguda (pescoço torce)
- mandíbula trava
- olhos rolam pra trás e não voltam - emergência na UPA que assusta
- mas é revertida com medicação na hora)
- febre com rigidez letal e sudorese (Síndrome Neuroléptica Maligna)
- espasmo da laringe (risco de sufocar)

Frase clínica

"Freio violento e de emergência para a perda completa de contato com a realidade, ao custo do engessamento robótico do corpo."

Cuidado ético

Não trate espasmos ou movimentos torcidos como "conversão histérica" ou "resistência" se o paciente tomar Haloperidol. É distonia medicamentosa perigosíssima. O paciente não "quer chamar atenção"; os nervos o traíram.

24 ZOLPIDEM

Hipnótico "Z-Drug". Na linguagem clínica: pílula sedativa pontual de ação exclusivamente indutora e curta (não garante o meio e fim do sono).

Nome

Zolpidem. Hemitartrato de zolpidem. Nomes comerciais: Stilnox, Patz, Lioram, Nuit.

Uso comum

Dificuldade esmagadora de indução (pegar) no sono em curto prazo. Uso crônico é controverso e perigoso.

O paciente pode relatar

- Foi mágico na primeira semana e agora não bate mais
- preciso de três pílulas pra capotar
- minha mulher disse que eu comi uma panela de macarrão de madrugada e não lembro
- acordei com a casa inteira desarrumada e sem memória
- mandei mensagem pro meu chefe dopado e acordei arrependido

O que observar em sessão

Reatividade noturna imprevisível. Amnésia anterógrada total severa após ingerir o medicamento (apaga a memória logo após). Tolerância subindo velozmente e paciente confessando dependência grave para conseguir encostar na cama.

Efeitos que confundem a leitura clínica

O paciente pode fazer desabaços passionais na sessão via WhatsApp ou e-mail de madrugada e no dia seguinte dizer que "foi sem querer", por estar de fato embriagado de zolpidem (efeito sonambúlico / amnésico extremo). Confusão matinal leve se misturado com outros remédios.

Perguntas úteis

- O que acontece logo depois que você engole a pílula? Você deita ou fica rodando no celular e pela casa?
- Quantos comprimidos está usando por noite?
- Você mistura com taça de vinho?
- Alguém já te contou coisas que você fez e não lembra de noite?

Amarelo: alinhar em breve

- Desespero se não tem medicação
- aumento progressivo de doses escondido
- uso antes de viagens de carro

Vermelho: tratar como urgência

- Relatos de condução de carro sob efeito sonambúlico
- tentativa de suicídio por ingestão maciça em momento dissociado
- alucinações nítidas e confusão delirante minutos após tomar se o paciente se recusa a deitar de imediato

Frase clínica

"A pílula do esquecimento curto que induz o sono rápido, mas pode despertar um zumbi funcional capaz de varrer a casa inteira e não lembrar de nada."

Cuidado ético

Relatos de "sonambulismo do Patz" merecem atenção clínica séria: o efeito amnésico do Zolpidem pode produzir comportamentos automáticos sem registro de memória. A orientação clínica consolidada é que o medicamento seja tomado já na cama, imediatamente antes de dormir.